बच्चों में रुग्णता एवं निवारण

Child Morbidity and Prevention

रुग्णता की संकल्पना (Concept of Morbidity)

रुग्णता (**Morbidity**) किसी व्यक्ति या जनसमूह में बीमारी, अस्वस्थता या स्वास्थ्य-संबंधी कठिनाई की उपस्थिति को व्यक्त करती है। बच्चों में इसका अध्ययन केवल अस्पताल में भर्ती होने से नहीं होता। बार-बार खाँसी, दस्त, दंत-क्षय, एनीमिया, अस्थमा और विकास संबंधी कठिनाइयाँ भी महत्त्वपूर्ण हैं।

बीमारी बच्चे की वृद्धि, भोजन, नींद, खेल, सीखने और परिवार की दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कम मृत्यु-दर का अर्थ यह नहीं कि सभी बच्चे बीमारी और अक्षमता से मुक्त हैं।

निवारण का व्यापक अर्थ (Meaning of Prevention)

निवारण में बीमारी होने से पहले जोखिम कम करना, शुरुआत में पहचानना, समय पर उपचार और आगे की जटिलताओं को घटाना शामिल है। कुछ दशाओं में बीमारी पूरी तरह रोकी जा सकती है; कुछ में उसके प्रभाव और बार-बार बिगड़ने की संभावना कम की जाती है।

अध्ययन का पक्ष	आवश्यक जानकारी
रोग का वितरण	कौन-सी बीमारी, किस आयु और कहाँ अधिक है?
आवृत्ति	कितने नए या मौजूद मामले हैं?
गंभीरता	दैनिक कार्य और स्वास्थ्य कितना प्रभावित हैं?
कार्रवाई	बचाव, उपचार और अनुवर्तन में क्या आवश्यक है?

बाल-केंद्रित दृष्टिकोण (Child-centred Approach)

बच्चे की आयु, पोषण, संचार क्षमता और परिवार के संसाधन देखकर सहायता तय होती है। केवल रोग का नाम पर्याप्त नहीं; उसके दैनिक जीवन में सहभागिता भी देखनी चाहिए।

> बाल स्वास्थ्य का उद्देश्य जीवित रहने के साथ स्वस्थ वृद्धि, विकास और अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करना है।

रुग्णता, मृत्यु और अक्षमता में अंतर

Morbidity, Mortality and Disability

संबंधित लेकिन अलग परिणाम (Different Health Outcomes)

रुग्णता बीमारी की उपस्थिति से जुड़ी है। मृत्यु (**Mortality**) जीवन की समाप्ति है। अक्षमता (**Disability**) स्वास्थ्य दशा, कार्यक्षमता और वातावरण की बाधाओं की परस्पर क्रिया से दैनिक सहभागिता प्रभावित होने से संबंधित है। ये शब्द एक-दूसरे के पर्याय नहीं हैं।

संकल्पना	उदाहरण
रुग्णता	बच्चे को निमोनिया या दंत-क्षय होना
मृत्यु	गंभीर रोग या चोट के बाद जीवन समाप्त होना
कार्यात्मक कठिनाई	दृष्टि कम होने से पुस्तक पढ़ने में बाधा
बीमारी का बोझ (**Disease Burden**)	आवृत्ति के साथ अवधि, गंभीरता और प्रभाव

तीव्र और दीर्घकालीन दशाएँ (Acute and Chronic Conditions)

तीव्र बीमारी (**Acute Illness**) अपेक्षाकृत अचानक शुरू होकर सीमित अवधि की हो सकती है। दीर्घकालीन दशा (**Chronic Condition**) लंबे समय तक चलती है या बार-बार देखभाल माँगती है। कम अवधि वाली बीमारी भी गंभीर और दीर्घकालीन बीमारी नियंत्रण में होने पर अपेक्षाकृत स्थिर हो सकती है।

संक्रामक और असंक्रामक रोग (Communicable and Noncommunicable Diseases)

संक्रामक रोगों में रोगकारक का संचरण संभव होता है; इसके रास्ते रोग के अनुसार भिन्न हैं। असंक्रामक दशाओं, जैसे अस्थमा या टाइप 1 मधुमेह, का एक बच्चे से दूसरे में सामान्य संक्रमण नहीं होता।

> बीमारी की अवधि, फैलने की क्षमता और गंभीरता तीन अलग विशेषताएँ हैं; एक से दूसरे का अनुमान न लगाएँ।

नए रोग-मामले और संचयी आपतन

New Cases and Cumulative Incidence

नए मामले की पहचान (Incidence)

आपतन (**Incidence**) किसी निश्चित अवधि में नए मामलों के उत्पन्न होने को बताता है। शुरुआत में पहले से रोगग्रस्त बच्चों को उसी रोग के नए मामलों के जोखिम वाले समूह में नहीं गिना जाता, यदि पहली बार रोग होने का अध्ययन हो रहा हो।

> संचयी आपतन = अवधि में नए रोगी ÷ शुरुआत में जोखिम वाले रोगमुक्त बच्चे × 100

गणना का उदाहरण (Worked Example)

किसी बंद समूह में शुरुआत में 800 बच्चे एक विशेष रोग से मुक्त थे। चार सप्ताह के पूरे अनुवर्तन में 40 बच्चों को वह रोग पहली बार हुआ।

> संचयी आपतन = 40 ÷ 800 × 100 = 5 प्रतिशत, चार सप्ताह में

यह अवधि-विशिष्ट जोखिम है। अवधि बताए बिना केवल 5 प्रतिशत लिखने से जानकारी अधूरी रहती है।

बच्चे और रोग-प्रकरण (Children versus Episodes)

एक बच्चे को वर्ष में दस्त के कई अलग प्रकरण हो सकते हैं। बीमार बच्चों की संख्या और रोग-प्रकरणों की संख्या समान नहीं होती। पहली बार बीमार होने का जोखिम तथा सभी प्रकरणों की आवृत्ति अलग संकेतक हैं।

गिनती का उद्देश्य	क्या गिना जाएगा?
कितने बच्चों को बीमारी हुई?	प्रत्येक संबंधित बच्चे को एक बार
कुल कितने अलग प्रकरण हुए?	परिभाषित प्रत्येक नया प्रकरण
कुल कितनी मुलाकातें हुईं?	स्वास्थ्य सुविधा की मुलाकातें

> एक ही बीमारी के लिए तीन बार अस्पताल आने को स्वतः तीन नए रोगी न मानें।

व्यक्ति-समय आपतन और प्रकोप की आक्रमण-दर

Person-time Incidence and Attack Rate

व्यक्ति-समय का आधार (Person-time Incidence Rate)

सभी बच्चों का अनुवर्तन समान समय तक न हो तो प्रत्येक बच्चे का वास्तविक जोखिम-अवलोकन समय जोड़कर व्यक्ति-समय प्राप्त किया जाता है। इसे बाल-वर्ष या बाल-माह में व्यक्त कर सकते हैं।

> आपतन-दर = नए मामले ÷ कुल जोखिम वाला व्यक्ति-समय

यदि 600 बाल-वर्ष के अवलोकन में 12 नए मामले उत्पन्न हों:

> आपतन-दर = 12 ÷ 600 × 1,000 = 20 प्रति 1,000 बाल-वर्ष

यह सीधे 20 प्रतिशत जोखिम नहीं है। व्यक्ति-समय दर और किसी निश्चित अवधि का अनुपात अलग प्रकार के माप हैं।

प्रकोप में आक्रमण-दर (Attack Rate)

एक सीमित प्रकोप में जोखिम वाले समूह का कितना हिस्सा बीमार हुआ, इसे प्रायः आक्रमण-दर कहते हैं। यह वास्तव में एक अनुपात है।

> आक्रमण-दर = प्रकोप के नए रोगी ÷ संबंधित जोखिम वाला समूह × 100

यदि एक सामूहिक भोजन के बाद संबंधित 200 प्रतिभागियों में 30 को परिभाषित बीमारी हुई, तो आक्रमण-दर 15 प्रतिशत होगी। केवल इस आँकड़े से किसी विशिष्ट भोजन को अंतिम कारण नहीं माना जा सकता; तुलना और जाँच चाहिए।

संकेतक का सही चुनाव (Choosing the Measure)

लंबे अनुवर्तन, अलग समय और सीमित प्रकोप के उद्देश्य अलग हैं। गणना से पहले मामले की परिभाषा और समय स्पष्ट करें।

> प्रतिशत, प्रति 1,000 बच्चे और प्रति 1,000 बाल-वर्ष को एक ही इकाई न समझें।

व्याप्तता और आपतन का अंतर

Prevalence versus Incidence

व्याप्तता की परिभाषा (Prevalence)

व्याप्तता को प्रचलन या प्रसार भी कहा जाता है। यह किसी निश्चित समय या अवधि में रोग वाले व्यक्तियों के हिस्से को बताती है। बिंदु व्याप्तता (**Point Prevalence**) में एक तय समय पर मौजूद पुराने और नए सभी संबंधित मामले शामिल होते हैं।

> बिंदु व्याप्तता = उस समय मौजूद रोगी ÷ उसी समय की संबंधित कुल जनसंख्या × 100

यदि एक दिन 1,000 बच्चों की जाँच में 70 बच्चों में कोई रोग मौजूद हो, तो व्याप्तता 7 प्रतिशत होगी।

अवधि व्याप्तता (Period Prevalence)

निर्धारित अवधि में किसी भी समय संबंधित रोग रहने वाले बच्चों को अवधि व्याप्तता में गिना जाता है। एक बच्चे के कई प्रकरण होने पर उसे उस अनुपात में बार-बार नहीं गिना जाता। जनसंख्या और अवधि का आधार स्पष्ट होना चाहिए।

पक्ष	आपतन	व्याप्तता
प्रमुख रुचि	नए मामले	सभी मौजूद संबंधित मामले
उपयोग	रोग उत्पन्न होने का जोखिम या गति	सेवा और देखभाल की वर्तमान जरूरत
अवधि का प्रभाव	नई घटनाओं की गिनती	रोग की अवधि और स्वस्थ होने से भी प्रभावित

व्याख्या (Interpretation)

लंबे समय रहने वाले रोग में व्याप्तता अधिक हो सकती है, भले नए मामले बहुत तेजी से न बढ़ें। बेहतर जीवन रक्षा से भी किसी दीर्घकालीन दशा के साथ जीवित बच्चों की संख्या बढ़ सकती है।

> अधिक व्याप्तता का अर्थ हमेशा अधिक नया संक्रमण या खराब उपचार नहीं; रोग की अवधि और जीवन रक्षा भी देखें।

रुग्णता का निरीक्षण और अभिलेखन

Observation and Recording of Morbidity

जानकारी के विविध रूप (Information for Assessment)

परिवार की रिपोर्ट, स्वास्थ्यकर्मी का परीक्षण, प्रयोगशाला जाँच, विद्यालय की अनुपस्थिति और उपचार-अभिलेख अलग प्रकार की जानकारी देते हैं। कोई एक अभिलेख सभी बच्चों की बीमारी का पूरा चित्र नहीं देता।

जानकारी	उपयोग और सीमा
परिवार का लक्षण-विवरण	शुरुआत और घर की स्थिति; स्मृति की त्रुटि संभव
चिकित्सीय परीक्षण	वर्तमान संकेत; पहले के सभी प्रकरण नहीं दिखते
प्रयोगशाला परिणाम	विशिष्ट रोग की पुष्टि में उपयोग; हर स्थिति में आवश्यक नहीं
अस्पताल के मामले	सेवा-उपयोग और गंभीरता; समुदाय का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं
विद्यालय अनुपस्थिति	कार्यात्मक प्रभाव; बीमारी के अतिरिक्त कारण भी संभव

मामले की परिभाषा (Case Definition)

अध्ययन में किस लक्षण, जाँच और अवधि को एक मामला माना जाएगा, यह पहले तय होना चाहिए। सामान्य खाँसी की गणना और चिकित्सीय निमोनिया की गणना समान नहीं है।

आँकड़ों की गुणवत्ता (Data Quality)

बार-बार मुलाकात को नया मामला मानना, आयु गलत लिखना या केवल उपचार लेने वालों को शामिल करना परिणाम बदल सकता है। समुदाय में सेवा न लेने वाले बीमार बच्चे अभिलेखों से छूट सकते हैं।

बीमारी-दिन, अस्पताल में बिताया समय और दैनिक काम में बाधा रोग के प्रभाव की अतिरिक्त जानकारी देते हैं। संख्या के साथ इनका अर्थ भी समझना चाहिए।

> रुग्णता का विश्वसनीय आकलन समान परिभाषा, उचित हर और पूर्ण अभिलेखन पर निर्भर है।

रुग्णता के निर्धारक: रोगकारक, मेजबान और वातावरण

Determinants: Agent, Host and Environment

रोग का त्रिक (Epidemiological Triad)

संक्रामक रोग समझने में रोगकारक (**Agent**), पोषक या मेजबान (**Host**) और वातावरण (**Environment**) का त्रिक उपयोगी है। केवल रोगाणु की मौजूदगी हर बच्चे में समान बीमारी और गंभीरता तय नहीं करती।

रोगकारक	मेजबान	वातावरण
Agent	Host	Environment
विषाणु, जीवाणु या अन्य कारक	आयु, पोषण और प्रतिरक्षा	संपर्क, आवास और सेवाएँ

मेजबान की संवेदनशीलता (Host Susceptibility)

आयु, प्रतिरक्षा, पोषण, टीकाकरण और पहले से मौजूद बीमारी बच्चे की संवेदनशीलता प्रभावित करते हैं। समयपूर्व जन्मे या विशेष स्वास्थ्य जरूरत वाले बच्चे को अलग सहायता चाहिए हो सकती है।

निर्धारक	संभावित भूमिका
रोगकारक की प्रकृति	संक्रमण करने की क्षमता और रोग का प्रकार
बच्चे की दशा	सुरक्षा, प्रतिरोध और बीमारी से उबरना
पर्यावरणीय संपर्क	पानी, हवा, आवास और वाहक
सामाजिक परिस्थितियाँ	भोजन, शिक्षा और सेवा तक पहुँच

व्यापक उपयोग की सीमा (Limits and Wider Context)

असंक्रामक रोगों में भी आनुवंशिक, पोषण और पर्यावरणीय प्रभाव साथ हो सकते हैं। इसलिए सभी रोगों को केवल एक संक्रमण-त्रिक में सीमित नहीं किया जा सकता।

बीमारी का जोखिम घटाने में बच्चे की सुरक्षा बढ़ाना, संपर्क कम करना और सेवाएँ सुलभ बनाना पूरक कार्य हैं। परिवार की आदत के साथ उसके वास्तविक संसाधन भी देखें।

> बीमारी को केवल कमजोर प्रतिरक्षा या केवल गंदगी का परिणाम बताना जटिल कारणों को अत्यधिक सरल बना देता है।

संक्रमण का संचरण और श्रृंखला तोड़ना

Transmission and Breaking the Chain

संक्रमण की श्रृंखला (Chain of Infection)

रोगकारक, उसका आश्रय, बाहर निकलने का मार्ग, संचरण का तरीका, प्रवेश का मार्ग और संवेदनशील व्यक्ति संक्रमण-श्रृंखला के भाग हैं। किसी उपयुक्त कड़ी पर हस्तक्षेप करने से संचरण घट सकता है।

प्रमुख मार्ग	उदाहरण	रोकथाम का आधार
श्वसन कण और हवा	खसरा तथा कुछ श्वसन संक्रमण	वायु-संचार, उपयुक्त सावधानी और टीकाकरण
मल-मुख मार्ग	अनेक दस्त तथा पोलियो संक्रमण	सुरक्षित पानी, हाथ और स्वच्छता
त्वचा का निकट संपर्क	स्केबीज	पहचान, उपचार और निकट संपर्कों का प्रबंधन
वाहक	मलेरिया या डेंगू	मच्छर से सुरक्षा और वाहक नियंत्रण
रक्त या शरीर-द्रव	कुछ विशिष्ट संक्रमण	सुरक्षित प्रक्रियाएँ और उपयुक्त बचाव

संचरण और गंभीरता (Transmission and Severity)

बहुत आसानी से फैलने वाला रोग हर व्यक्ति में समान गंभीर हो, यह आवश्यक नहीं है। बिना स्पष्ट लक्षण वाला व्यक्ति भी कुछ संक्रमण फैला सकता है। उपयुक्त उपाय रोग के मार्ग और स्थिति पर निर्भर हैं।

परिवार और समुदाय (Family and Community)

बच्चे की उम्र के अनुसार खाँसते समय मुँह ढकना, हाथ धोना और साझा सामग्री की सफाई सिखाएँ। बीमार बच्चे को अलग करने की जरूरत हो तो सम्मान और देखभाल बनाए रखें। अनावश्यक सामाजिक बहिष्कार उचित नहीं है।

> सभी संक्रमण एक जैसे नहीं फैलते; सही बचाव के लिए संचरण का रास्ता समझना आवश्यक है।

आयु के अनुसार रुग्णता की प्रकृति

Age-related Patterns of Morbidity

बदलते जोखिम (Age-related Patterns)

बच्चे की आयु के साथ शारीरिक तैयारी, भोजन, संपर्क और दैनिक गतिविधियाँ बदलती हैं। इसलिए सामान्य रोग तथा उनकी गंभीरता की संभावना भी बदलती है।

अवस्था	प्रमुख ध्यान के क्षेत्र
नवजात और छोटा शिशु	भोजन की कठिनाई, संक्रमण, ताप तथा जन्म-संबंधी दशाएँ
बाद की शैशवावस्था	श्वसन संक्रमण, दस्त, पोषण और टीकाकरण
प्रारंभिक बाल्यावस्था	संक्रमण, कृमि, त्वचा-दंत समस्या और सुरक्षित खोज
विद्यालयी आयु	दृष्टि-श्रवण, दंत स्वास्थ्य, पोषण, अस्थमा और सीखने की सहभागिता

व्यक्ति की विशेषता (Individual Context)

एक ही आयु के बच्चों में पोषण, पहले से रोग और सामाजिक अवसर भिन्न हो सकते हैं। सामान्य सूची किसी बच्चे का निश्चित निदान नहीं है। समयपूर्व जन्म, दीर्घकालीन बीमारी और प्रतिरक्षा-संबंधी दशाओं में विशेष सावधानी आवश्यक हो सकती है।

सेवाओं का अनुकूलन (Age-appropriate Care)

छोटे शिशु अपनी परेशानी शब्दों में नहीं बताते। दूध कम पीना या कम सक्रिय होना महत्त्वपूर्ण संकेत हो सकता है। बड़े बच्चे दर्द, थकान और स्कूल की कठिनाई बता सकते हैं; उनकी बात सुनना आवश्यक है।

किशोरावस्था में बदलती जरूरतों के लिए भी आयु-अनुकूल संवाद और सेवा चाहिए। बचपन की सभी स्वास्थ्य स्थितियों को केवल पाँच वर्ष से कम आयु तक सीमित न मानें।

> आयु रोग की संभावना और कार्रवाई की तात्कालिकता को प्रभावित करती है; लक्षण का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलता है।

सामान्य सर्दी, खाँसी और कान की समस्या

Common Cold, Cough and Ear Problems

ऊपरी श्वसन संक्रमण (Upper Respiratory Infection)

नाक बहना, गले में असुविधा और खाँसी के बहुत-से सामान्य प्रकरण विषाणुजनित होते हैं। हर सर्दी में एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती। अवधि के साथ श्वसन, भोजन, सक्रियता और बीमारी का क्रम देखना महत्त्वपूर्ण है।

उपयुक्त विश्राम, आयु-अनुकूल द्रव तथा भोजन और नाक की देखभाल में सहायता उपयोगी हो सकती है। छोटे बच्चों को अपने से मिश्रित खाँसी-सर्दी की दवा देना सुरक्षित सामान्य उपाय नहीं है।

मध्यकर्ण संक्रमण (Otitis Media)

कान में दर्द, बुखार, सुनने में कमी या कान से बहाव परीक्षण की जरूरत बता सकते हैं। छोटे बच्चे कान छू सकते हैं, लेकिन केवल कान पकड़ना निदान नहीं है। बार-बार संक्रमण से सुनने और भाषा के अवसर प्रभावित हो सकते हैं।

स्थिति	उचित दिशा
हल्की सर्दी, सक्रिय बच्चा	निरीक्षण और समर्थक देखभाल
कान-दर्द या बहाव	योग्य स्वास्थ्य परीक्षण
कठिन श्वसन या सुस्ती	शीघ्र गंभीरता का आकलन
बार-बार सुनने की कठिनाई	श्रवण तथा कान की जाँच

लंबे समय की खाँसी, भार न बढ़ना या टीबी रोगी से निकट संपर्क होने पर क्षयरोग (**Tuberculosis**) सहित उपयुक्त मूल्यांकन आवश्यक है। बच्चों में लक्षण हमेशा वयस्क जैसे नहीं होते।

बचाव (Prevention)

धुएँ से बचाव, हाथों की सफाई, उपयुक्त टीकाकरण और स्तनपान सहायक हैं। कान में तेल, नुकीली वस्तु या अनिर्दिष्ट दवा डालना नुकसान पहुँचा सकता है।

> खाँसी का केवल स्वर या नाक के स्राव का रंग देखकर एंटीबायोटिक की जरूरत तय नहीं होती।

निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस और श्वसन-गंभीरता

Pneumonia, Bronchiolitis and Respiratory Severity

अलग स्थितियों का अंतर (Different Respiratory Conditions)

निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। ब्रोंकियोलाइटिस छोटे बच्चों में छोटी श्वसन-नलिकाओं की प्रायः विषाणुजनित बीमारी है। सीटी जैसी आवाज (**Wheeze**) कई स्थितियों में हो सकती है; हर बार उसका अर्थ अस्थमा या जीवाणु संक्रमण नहीं है।

आयु के अनुसार तेज श्वसन (Age-specific Fast Breathing)

आम बाल-आकलन में शांत बच्चे की साँसें पूरे एक मिनट गिनी जाती हैं।

आयु	तेज श्वसन की सामान्य आकलन-सीमा
2 माह से कम	60 या अधिक प्रति मिनट; पुनः गिनती से पुष्टि
2 माह से 12 माह से कम	50 या अधिक प्रति मिनट
12 माह से 5 वर्ष से कम	40 या अधिक प्रति मिनट

ये प्रशिक्षित आकलन के संकेत हैं। रोना, बुखार और स्थिति दर प्रभावित कर सकते हैं। अकेली संख्या से रोग का अंतिम निदान या उपचार तय नहीं होता।

गंभीरता और कार्रवाई (Severity and Action)

छाती धँसना, बहुत अधिक श्वसन-प्रयास, नीलापन, पी न पाना या असामान्य सुस्ती में शीघ्र चिकित्सा आवश्यक है। ऑक्सीजन की कमी का मूल्यांकन और उपयुक्त उपचार महत्त्वपूर्ण हैं।

निमोनिया में चिकित्सक आवश्यक एंटीबायोटिक तय करते हैं। ब्रोंकियोलाइटिस के हर प्रकरण में वही औषधियाँ स्वतः उपयोग करना उचित नहीं है।

> बच्चे की आयु, संपूर्ण स्थिति और श्वसन-प्रयास को साथ देखें; केवल खाँसी की दवा से गंभीर श्वसन समस्या का उपचार नहीं होता।

दस्त: प्रकार, कारण और निर्जलीकरण

Diarrhoea: Types, Causes and Dehydration

परिभाषा और प्रकार (Definition and Types)

एक दिन में तीन या अधिक ढीले या पानी जैसे मल, अथवा व्यक्ति के सामान्य से अधिक बार ऐसा मल आना दस्त है। स्तनपान करने वाले छोटे शिशु का सामान्य नरम मल स्वतः बीमारी नहीं है; उसके सामान्य क्रम और अन्य संकेत देखें।

प्रकार	पहचान
तीव्र जलीय दस्त (**Acute Watery Diarrhoea**)	पानी जैसे मल; सामान्यतः 14 दिन से कम अवधि
पेचिश (**Dysentery**)	मल में दिखाई देने वाला रक्त
लगातार दस्त (**Persistent Diarrhoea**)	14 दिन या अधिक अवधि तक दस्त

पेचिश को केवल किसी एक परजीवी का रोग न मानें; अलग संक्रमण कारण हो सकते हैं। जाँच और उपचार स्थिति के अनुसार तय होते हैं।

निर्जलीकरण (Dehydration)

दस्त में पानी तथा लवण की हानि होती है। प्यास, पेशाब कम होना, आँखें धँसना, चिड़चिड़ापन या सुस्ती महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। गंभीरता कई संकेत और परीक्षण से तय की जाती है।

खतरे के संकेत (Warning Signs)

बच्चा पी न सके, बहुत सुस्त हो, लगातार सब उलट दे या स्थिति तेजी से बिगड़े तो तत्काल सेवा चाहिए। मल में रक्त, लंबी अवधि के दस्त और छोटे शिशु की बीमारी पर चिकित्सा मूल्यांकन आवश्यक है।

सुरक्षित पानी, भोजन, हाथों की स्वच्छता और उपयुक्त टीकाकरण जोखिम घटाते हैं।

> दस्त के उपचार में द्रव-पूर्ति और भोजन महत्त्वपूर्ण हैं; केवल मल बंद करने को स्वस्थ होना न मानें।

ORS, जिंक और दस्त की देखभाल

ORS, Zinc and Diarrhoea Care

मौखिक पुनर्जलीकरण (Oral Rehydration)

ORS पानी और इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति के लिए है। छोटी आँत में सोडियम तथा ग्लूकोज का संयुक्त परिवहन पानी के अवशोषण को सहारा देता है। इसलिए ORS केवल मीठा पेय या दस्त रोकने की औषधि नहीं है।

सही घोल बनाने की प्रक्रिया (Correct Preparation)

1	पैकेट जाँचें	कितने पानी के लिए है, निर्देश पढ़ें।
2	सही पानी मापें	सुरक्षित पानी की निर्धारित मात्रा लें।
3	पूरा पैकेट घोलें	अतिरिक्त सामग्री मिलाए बिना घोल बनाएँ।
4	सुरक्षित रखें और दें	साफ पात्र, छोटे घूँट और सही निगरानी।

पैकेट अलग पानी की मात्रा के लिए हो सकते हैं। पूरे पैकेट को उसी पर लिखी ठीक मात्रा में सुरक्षित पानी में घोलें। अपने से अतिरिक्त नमक, चीनी, दूध या रस न मिलाएँ। तैयार घोल को ढककर रखें, दूषित होने पर त्याग दें और 24 घंटे बाद बचा घोल फेंककर नया बनाएँ।

जिंक और अन्य उपचार (Zinc and Other Treatment)

जिंक दस्त के प्रबंधन का उपयोगी सहायक है। उसकी खुराक और अवधि बच्चे तथा लागू चिकित्सीय प्रोटोकॉल के अनुसार स्वास्थ्यकर्मी तय करें। यह ORS का स्थान नहीं लेता। हर दस्त में एंटीबायोटिक या दस्त रोकने की औषधि आवश्यक नहीं है।

कब घरेलू देखभाल पर्याप्त नहीं? (When Further Care Is Needed)

गंभीर निर्जलीकरण, पी न पाना, अचेतना या अन्य गंभीर बीमारी में चिकित्सीय द्रव और निगरानी आवश्यक हो सकती है। निगल न सकने वाले या अचेत बच्चे को जबरन मुँह से द्रव देना असुरक्षित है।

> ORS की सही पहचान, सही पानी की मात्रा और समय पर रेफरल उसके उपयोग जितने ही महत्त्वपूर्ण हैं।

बीमारी में भोजन और पुनर्प्राप्ति

Feeding during Illness and Recovery

बीमारी-पोषण का संबंध (Illness and Nutrition)

बीमारी में भूख कम, ऊर्जा की जरूरत अधिक और पोषक हानि हो सकती है। पर्याप्त भोजन न मिलने से कमजोरी बढ़ती है और स्वस्थ होने में समय लग सकता है। बार-बार बीमारी तथा अल्पपोषण एक-दूसरे को बढ़ा सकते हैं।

भोजन जारी रखना (Continued Feeding)

उपयुक्त स्थिति में स्तनपान जारी रखें। बड़े शिशु और बच्चे को उम्र तथा सहनशीलता के अनुसार छोटी मात्रा में बार-बार पौष्टिक भोजन दें। केवल पानी, पतली चाय या बहुत मीठे पेय पर निर्भर रहना पर्याप्त पोषण नहीं है।

स्थिति	उपयोगी दिशा
भूख कम	छोटी मात्रा, अधिक अवसर और शांत सहायता
दस्त	द्रव-पूर्ति के साथ उपयुक्त भोजन जारी
सामान्य सुधार	परिवार के विविध पौष्टिक भोजन पर वापसी
भोजन निगलने में कठिनाई	चिकित्सीय मूल्यांकन और सुरक्षित योजना

स्वस्थ होने के बाद (Recovery)

भूख लौटने पर आयु-अनुकूल अतिरिक्त पौष्टिक भोजन और वृद्धि की समीक्षा उपयोगी है। वजन का अस्थायी बदलाव, बीमारी की अवधि और पहले की वृद्धि-प्रवृत्ति साथ देखें। लगातार कम भोजन, भार न बढ़ना या बार-बार बीमारी में सहायता लें।

व्यवहार का महत्त्व (Responsive Feeding)

जबरन खिलाना या भोजन को दंड बनाना परेशानी बढ़ा सकता है। गंभीर रोग में विशेष आहार और पोषण-उपचार की जरूरत हो सकती है; सामान्य घरेलू सुझाव उसका विकल्प नहीं है।

> बीमारी के समय पोषण रोकना और सुधार के बाद वृद्धि की अनदेखी करना दोनों से बचना चाहिए।

बुखार और ज्वरजनित दौरे

Fever and Febrile Seizures

बुखार का अर्थ (Fever)

बुखार एक संकेत है, अपने आप में किसी एक रोग का नाम नहीं। संक्रमण सहित अनेक स्थितियाँ ताप बढ़ा सकती हैं। आयु, ताप मापने की विधि, सक्रियता, श्वसन और अन्य लक्षणों के साथ उसका अर्थ समझें।

तीन माह से कम आयु के शिशु में 38°C या अधिक मापा ताप होने पर तुरंत चिकित्सा सलाह और मूल्यांकन आवश्यक है। बड़े बच्चे में भी कठिन श्वसन, बहुत सुस्ती, निर्जलीकरण या तेजी से बिगड़ना गंभीर संकेत हैं।

ज्वरजनित दौरा (Febrile Seizure)

कुछ बच्चों में लगभग छह माह से पाँच वर्ष के बीच बुखार के साथ दौरा हो सकता है। हर दौरा ज्वरजनित नहीं है; कारण की चिकित्सीय जाँच आवश्यक है। साधारण ज्वरजनित दौरे और मिर्गी को समान न मानें।

दौरे के समय	आवश्यक व्यवहार
चोट से बचाव	आसपास की कठोर या नुकीली वस्तु हटाएँ
सुरक्षित स्थिति	जहाँ सुरक्षित संभव हो, करवट रखें और श्वसन देखें
मुँह और शरीर की सुरक्षा	मुँह में कुछ न ठूँसें; हाथ-पैर न जकड़ें; पानी या दवा जबरन न दें
अवधि	समय नोट करें; दौरा 5 मिनट तक जारी रहे तो आपात सहायता लें

उपचार संबंधी सावधानी (Treatment Caution)

पहला दौरा, बार-बार दौरे, श्वसन समस्या या ठीक से चेतना न लौटना तत्काल मूल्यांकन के कारण हैं। बुखार कम करने वाली दवा आराम दे सकती है, लेकिन ज्वरजनित दौरा रोकने की गारंटी नहीं है।

> ताप की संख्या के साथ बच्चे की आयु और संपूर्ण स्थिति देखें; गंभीर संकेतों पर केवल दवा का असर आने की प्रतीक्षा न करें।

खसरा, रूबेला और छोटी माता

Measles, Rubella and Chickenpox

बुखार के साथ दाने (Fever with Rash)

दाने और बुखार के अनेक कारण हो सकते हैं। खसरा, रूबेला और छोटी माता अलग विषाणुजनित रोग हैं। केवल तस्वीर या दानों का रंग देखकर अंतिम निदान नहीं किया जाता।

रोग	प्रमुख संकेत	महत्त्वपूर्ण बचाव
खसरा (**Measles**)	बुखार, खाँसी, नाक बहना, आँखें लाल और बाद में दाने	खसरा-युक्त टीकाकरण और संक्रमण नियंत्रण
रूबेला (**Rubella**)	प्रायः हल्का बुखार, दाने और लसीका-ग्रंथि बढ़ना	रूबेला-युक्त टीका; गर्भवती के संपर्क से बचाव
छोटी माता (**Chickenpox**)	खुजली वाले दाने और फफोले; अलग चरण साथ दिख सकते हैं	उपयुक्त टीकाकरण पर परामर्श और संपर्क-नियंत्रण

जटिलताएँ और अलग महत्त्व (Different Risks)

खसरे में निमोनिया, दस्त और अन्य गंभीर जटिलताएँ हो सकती हैं। रूबेला गर्भावस्था में भ्रूण के लिए विशेष जोखिम रखता है। छोटी माता में त्वचा का जीवाणु संक्रमण या अन्य जटिलताएँ हो सकती हैं।

खसरा और छोटी माता बहुत आसानी से फैल सकते हैं। बीमार बच्चे की देखभाल, उपयुक्त अलगाव और उपचार की व्यवस्था स्वास्थ्यकर्मी के निर्देश के अनुसार करें। बिना सुरक्षित देखभाल के केवल अलग कमरे में छोड़ देना उचित नहीं है।

राष्ट्रीय और अतिरिक्त टीके (Vaccine Context)

MR खसरा तथा रूबेला से सुरक्षा के लिए है; यह छोटी माता का टीका नहीं है। सभी उपलब्ध टीके राष्ट्रीय सार्वजनिक अनुसूची में समान रूप से शामिल नहीं होते।

> दाने वाले रोगों के नाम मिलाने से उपचार और संपर्क-सुरक्षा दोनों में गलती हो सकती है।

डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटनेस और पोलियो

Diphtheria, Pertussis, Tetanus and Polio

अलग रोग, अलग संचरण (Different Diseases and Routes)

इन रोगों के विरुद्ध टीकाकरण महत्त्वपूर्ण है, लेकिन उनका रोगकारक और संचरण एक जैसा नहीं है। बूस्टर तथा छूटी खुराक की समीक्षा भी जरूरी है।

रोग	प्रमुख पहचान	संचरण संबंधी मुख्य बात
डिप्थीरिया (**Diphtheria**)	गले में झिल्ली, विष के कारण गंभीर अंग-हानि संभव	श्वसन स्राव या निकट संपर्क
काली खाँसी (**Pertussis**)	बार-बार तीव्र खाँसी; छोटे शिशु में साँस रुकना भी	संक्रमित श्वसन कण
टिटनेस (**Tetanus**)	मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन	दूषित घाव से बीजाणु प्रवेश; व्यक्ति से व्यक्ति नहीं
पोलियो (**Poliomyelitis**)	कुछ मामलों में तीव्र ढीला पक्षाघात	मुख्यतः मल-मुख संचरण

बचाव की संयुक्त भूमिका (Combined Prevention)

निर्धारित टीकाकरण, स्वच्छ प्रसव और घाव की सही देखभाल उपयोगी हैं। नवजात टिटनेस से बचाव में मातृ टीकाकरण और सुरक्षित नाल देखभाल दोनों का महत्त्व है। नाल पर मिट्टी या अन्य अनिर्दिष्ट पदार्थ न लगाएँ।

जल्दी पहचान (Early Recognition)

छोटे शिशु में साँस रुकना, गंभीर गले की समस्या, ऐंठन या अचानक पक्षाघात तत्काल चिकित्सा के कारण हैं। विशेष रोग की आशंका पर निगरानी व्यवस्था को सूचना देना स्वास्थ्य सेवा का काम है।

टीका लगने से हर व्यक्ति में हर संक्रमण का शून्य जोखिम नहीं हो जाता, लेकिन संबंधित बीमारी और गंभीर परिणामों से सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण आधार मिलता है।

> टिटनेस जीवाणु से होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति-से-व्यक्ति संपर्क से नहीं फैलता।

मलेरिया, डेंगू और वाहकजनित रुग्णता

Malaria, Dengue and Vector-borne Illness

रोग और मच्छर में अंतर (Diseases and Vectors)

मलेरिया परजीवीजनित और डेंगू विषाणुजनित रोग है। दोनों का बुखार समान दिखाई दे सकता है, लेकिन जाँच, उपचार और वाहक अलग हैं।

पक्ष	मलेरिया (Malaria)	डेंगू (Dengue)
रोगकारक	प्लाज्मोडियम परजीवी	डेंगू विषाणु
प्रमुख वाहक	संक्रमित मादा एनोफिलीज	संक्रमित एडीज मच्छर
प्रमुख काटने का समय	प्रायः शाम-रात	मुख्यतः दिन में
जोखिम घटाना	उपयुक्त मच्छरदानी और स्थानीय नियंत्रण	कंटेनर का पानी हटाना तथा काटने से सुरक्षा

काटने का समय पूर्ण प्रतिबंधित सीमा नहीं है। केवल रात की सुरक्षा सभी प्रकार के मच्छर-जोखिम को नहीं रोकती।

गंभीरता के संकेत (Warning Signs)

डेंगू में तेज पेट-दर्द, लगातार उलटी, रक्तस्राव, अधिक सुस्ती या बेचैनी और श्वसन कठिनाई गंभीर संकेत हो सकते हैं। बुखार उतरने के बाद भी स्थिति बिगड़ सकती है। मलेरिया में चेतना, श्वसन या गंभीर कमजोरी की समस्या तत्काल सेवा माँगती है।

निवारण और सही उपचार (Prevention and Care)

पानी के पात्र ढकें, अनावश्यक ठहरा पानी हटाएँ और आयु-अनुकूल मच्छर-सुरक्षा अपनाएँ। अपने से एंटीबायोटिक, मलेरिया की दवा या डेंगू में एस्पिरिन-इबुप्रोफेन लेना उचित नहीं है। चिकित्सक रोग तथा स्थिति के अनुसार उपचार तय करते हैं।

> हर बुखार को मलेरिया और केवल प्लेटलेट कम होने को डेंगू का अंतिम प्रमाण न मानें।

कृमि संक्रमण और निवारण

Worm Infections and Prevention

संचरण के अलग रास्ते (Routes of Worm Infection)

कृमि बच्चे के पोषण, एनीमिया, पेट संबंधी लक्षण और दैनिक कार्य पर प्रभाव डाल सकते हैं। हर कृमि समान रास्ते से नहीं फैलता और हर पेट-दर्द कृमि के कारण नहीं होता।

कृमि-समूह	प्रमुख संचरण या विशेषता
गोलकृमि (**Roundworm**)	दूषित मिट्टी, भोजन या हाथ से अंडों का निगलना
हुकवर्म (**Hookworm**)	दूषित मिट्टी में लार्वा का त्वचा से प्रवेश; रक्त-हानि संभव
पिनवर्म (**Pinworm**)	अंडों का हाथ-मुँह संपर्क; रात में गुदा के आसपास खुजली

प्रमुख बचाव (Prevention)

शौचालय का उपयोग, सुरक्षित मल निस्तारण, भोजन से पहले और शौच के बाद हाथ धोना, नाखून साफ रखना और उपयुक्त जूते पहनना उपयोगी हैं। फलों-सब्जियों की सुरक्षित सफाई और पानी की गुणवत्ता भी महत्त्वपूर्ण है।

कृमिनाशन और जाँच (Deworming and Assessment)

सार्वजनिक कृमिनाशन कार्यक्रम में दवा तय आयु और कार्यक्रम के अनुसार दी जाती है। रोगी बच्चे का उपचार उसकी स्थिति और कृमि के प्रकार के अनुसार बदल सकता है। सामूहिक खुराक हर परजीवी रोग का पूरा उपचार नहीं है।

एनीमिया, भार न बढ़ना, लगातार पेट-दर्द या अन्य लक्षणों में उपयुक्त मूल्यांकन करें। केवल मीठा खाने से कृमि पैदा नहीं होते और दाँत पीसना अपने आप में निश्चित निदान नहीं है।

> कृमिनाशन के साथ स्वच्छता और पुनःसंक्रमण से बचाव आवश्यक है।

त्वचा के रोग: स्केबीज, दाद और एक्जिमा

Scabies, Tinea and Eczema

समान खुजली, अलग कारण (Different Causes of Itching)

खुजली, लालिमा या चकत्ता कई दशाओं में हो सकता है। स्केबीज परजीवी, दाद कवकीय और एक्जिमा प्रायः असंक्रामक सूजन-संबंधी समस्या है। इनका उपचार एक जैसा नहीं होता।

दशा	सामान्य पहचान	निवारण या देखभाल
स्केबीज (**Scabies**)	तीव्र खुजली; परिवार में अन्य सदस्यों को भी हो सकती है	निर्धारित उपचार और निकट संपर्कों का साथ प्रबंधन
दाद (**Tinea**)	त्वचा का कवकीय संक्रमण; सिर पर बाल झड़ना भी	सही कवकरोधी उपचार और साझा सामग्री की सावधानी
एक्जिमा (**Eczema**)	सूखी, खुजली वाली सूजनयुक्त त्वचा	त्वचा की नमी और चिकित्सीय योजना
सिर की जूँ (**Head Lice**)	सिर में खुजली; बालों से जुड़े अंडे	उचित पहचान, उपचार और निकट संपर्क की समीक्षा

गलत उपचार से बचाव (Avoiding Inappropriate Treatment)

दाद पर अपने से स्टेरॉयड-मिश्रित क्रीम लगाने से रूप बदल सकता है और समस्या बढ़ सकती है। सिर की जूँ के लिए कीटनाशक, केरोसिन या घरेलू विषैले पदार्थ उपयोग करना असुरक्षित है।

सम्मानपूर्ण व्यवहार (Respectful Care)

त्वचा रोगों के कारण बच्चे को गंदा या दोषी कहना उचित नहीं। लगातार खुजली नींद और सीखने को प्रभावित कर सकती है। पस, दर्द, बुखार या तेजी से फैलती समस्या पर चिकित्सा लें।

> हर खुजली संक्रामक नहीं और हर चकत्ता एलर्जी नहीं; कारण की सही पहचान आवश्यक है।

आँख, कान और मुख की स्वास्थ्य समस्याएँ

Eye, Ear and Oral Health Problems

दैनिक कार्य पर प्रभाव (Effects on Daily Function)

दृष्टि, श्रवण और दंत समस्या भोजन, संवाद, नींद और विद्यालयी सहभागिता प्रभावित कर सकती है। बच्चा समस्या स्पष्ट न बताए तो व्यवहार के संकेत देखना उपयोगी है।

क्षेत्र	देखे जा सकने वाले संकेत	आवश्यक दिशा
दृष्टि	बहुत पास से देखना, बोर्ड न दिखना, भेंगापन	उपयुक्त दृष्टि तथा आँख का परीक्षण
श्रवण	आवाज पर कम प्रतिक्रिया, बार-बार पूछना, भाषा में कठिनाई	कान और श्रवण का मूल्यांकन
दंत स्वास्थ्य	दर्द, दाँत में छेद, चबाने में कठिनाई	दंत उपचार तथा दैनिक सफाई
आँख का संक्रमण	लालिमा और स्राव	कारण के अनुसार देखभाल; स्वच्छता

दंत-क्षय की रोकथाम (Dental Caries Prevention)

बार-बार मीठे पदार्थ तथा पेय, अपर्याप्त सफाई और उपयुक्त फ्लोराइड की कमी दंत-क्षय से जुड़ते हैं। वयस्क की सहायता से दिन में दो बार आयु-अनुकूल मात्रा में फ्लोराइड टूथपेस्ट से सफाई और मीठे संपर्क कम करना उपयोगी है।

दूध के दाँत भी महत्त्वपूर्ण हैं; “बाद में गिर जाएँगे” कहकर दर्द या संक्रमण को टालना उचित नहीं है।

शीघ्र चिकित्सा की स्थितियाँ (Urgent Concerns)

अचानक दृष्टि घटना, तेज आँख-दर्द, रासायनिक चोट या गंभीर सूजन में तत्काल सेवा लें। कान में नुकीली वस्तु या अनिर्दिष्ट दवा न डालें।

> कम सुनना या कम दिखना सीखने की कठिनाई जैसा दिखाई दे सकता है; बच्चे को आलसी कहने से पहले स्वास्थ्य पक्ष जाँचें।

कब्ज, पेट-दर्द और मूत्र संक्रमण

Constipation, Abdominal Pain and UTI

कब्ज की पहचान (Constipation)

कठोर या दर्दपूर्ण मल, मल रोकना और कठिनाई से शौच होना कब्ज के संकेत हो सकते हैं। केवल प्रतिदिन मल न आना हर बच्चे में कब्ज नहीं है; उम्र, भोजन और सामान्य क्रम देखें।

मल रोकने, दर्द और फिर अधिक कठोर मल का चक्र बन सकता है। आयु-अनुकूल रेशा, द्रव, सक्रियता तथा बिना दबाव नियमित शौच-अवसर उपयोगी हैं। कुछ बच्चों को चिकित्सीय औषधि की भी आवश्यकता होती है।

मूत्र मार्ग संक्रमण (Urinary Tract Infection: UTI)

बड़े बच्चे में पेशाब में जलन, बार-बार पेशाब या पेट-दर्द हो सकता है। छोटे बच्चे में बुखार, दूध कम पीना या असामान्य चिड़चिड़ापन जैसे अस्पष्ट संकेत भी मिल सकते हैं। सही नमूने की जाँच और उपयुक्त उपचार महत्त्वपूर्ण हैं।

समस्या	सावधानी
बार-बार पेट-दर्द	भोजन, मल, तनाव और अन्य कारणों का मूल्यांकन
पेशाब संबंधी लक्षण	मूत्र संक्रमण की संभावना की जाँच
कब्ज	दर्द और मल रोकने की आदत को साथ समझना
लगातार उलटी, पेट फूलना या रक्त	शीघ्र चिकित्सीय आकलन

दैनिक बचाव (Daily Prevention)

उपयुक्त पानी, शौच की सुविधा, स्वच्छता और पेशाब लंबे समय न रोकना सहायक हैं। बच्चे को दुर्घटना या मल-संबंधी कठिनाई पर शर्मिंदा न करें।

> हर पेट-दर्द को कृमि और हर पेशाब की समस्या को कम पानी का परिणाम मानना उचित नहीं है।

अल्पपोषण और तीव्र पोषण-संबंधी रुग्णता

Undernutrition and Acute Nutritional Illness

अलग संकेतक (Different Nutrition Indicators)

दुबलापन (**Wasting**) लंबाई या ऊँचाई के अनुसार कम भार, ठिगनापन (**Stunting**) आयु के अनुसार कम लंबाई या ऊँचाई और कम भार (**Underweight**) आयु के अनुसार कम वजन बताता है। ये एक-दूसरे के पूर्ण विकल्प नहीं हैं।

गंभीर तीव्र अल्पपोषण (Severe Acute Malnutrition)

6 से 59 माह के बच्चों में निम्न में से कोई उपयुक्त मानदंड गंभीर तीव्र अल्पपोषण पहचानने का आधार हो सकता है:

मानदंड	सीमा या पहचान
मध्य ऊपरी बाँह की परिधि (**MUAC**)	11.5 सेमी से कम
लंबाई या ऊँचाई के अनुसार भार का Z-score	-3 से कम
पोषण-संबंधी शोफ	दोनों पैरों पर दबाने से गड्ढा रहने वाला शोफ

ये तीनों एक साथ होना आवश्यक नहीं है। शोफ के अन्य कारणों और बच्चे की संपूर्ण स्थिति का चिकित्सीय मूल्यांकन जरूरी है। यह MUAC सीमा छोटे शिशुओं या सभी आयु पर स्वतः लागू नहीं होती।

जटिलता और सहायता (Complications and Support)

भूख न लगना, संक्रमण, सुस्ती या अन्य खतरे के संकेतों में विशेष सुविधा-आधारित उपचार चाहिए हो सकता है। सभी बच्चों में एक ही घरेलू उच्च-कैलोरी आहार पर्याप्त या सुरक्षित नहीं है।

भोजन-सुरक्षा, नियमित वृद्धि निगरानी, उपयुक्त पूरक आहार और संक्रमण प्रबंधन पुनःरुग्णता घटाने में मदद करते हैं।

> बच्चे को केवल पतला देखकर गंभीरता तय न करें; माप, शोफ, भूख और चिकित्सीय स्थिति साथ देखें।

एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी

Anaemia and Micronutrient Deficiencies

एनीमिया की संकल्पना (Anaemia)

आयु और संदर्भ के अनुरूप हीमोग्लोबिन कम होना एनीमिया है। थकान, पीलापन और ध्यान में कठिनाई हो सकती है, लेकिन केवल दिखावट से उसकी पुष्टि नहीं होती। आयरन की कमी सामान्य कारण है; सभी एनीमिया केवल आयरन की कमी से नहीं होते।

संक्रमण, अन्य पोषक कमियाँ और हीमोग्लोबिन संबंधी वंशानुगत दशाएँ भी कारण हो सकती हैं। उपचार कारण के अनुरूप तय होना चाहिए।

कमी या दशा	संभावित प्रमुख प्रभाव	बचाव का आधार
आयरन की कमी	एनीमिया, थकान और कार्यक्षमता में कमी	आयरनयुक्त आहार तथा आवश्यक पूरक
विटामिन A की कमी	रतौंधी, आँख की शुष्कता और अन्य प्रभाव	विविध भोजन तथा कार्यक्रम-अनुसार पूरक
विटामिन D संबंधी कमी	रिकेट्स और अस्थि-समस्या	पोषण और उपयुक्त चिकित्सीय सलाह
आयोडीन की कमी	थायरॉयड और वृद्धि-विकास प्रभावित	उचित आयोडीनयुक्त नमक

एकीकृत देखभाल (Integrated Care)

उचित आहार, कृमि और संक्रमण का प्रबंधन तथा कार्यक्रम के अनुसार पूरक सहायता उपयोगी हैं। गंभीर पीलापन, श्वसन कठिनाई या अत्यधिक कमजोरी पर शीघ्र चिकित्सा लें।

पूरक की मात्रा उम्र, दशा और लागू प्रोटोकॉल पर निर्भर होती है। अधिक मात्रा लेना अधिक लाभ का प्रमाण नहीं है।

> पोषण की कमी का उपचार केवल एक खाद्य पदार्थ या बिना जाँच दी गई दवा तक सीमित न करें।

अस्थमा, एलर्जी और बार-बार श्वसन समस्या

Asthma, Allergy and Recurrent Respiratory Symptoms

अस्थमा का स्वरूप (Asthma)

अस्थमा वायुमार्ग की दीर्घकालीन सूजन और बदलते संकुचन से संबंधित है। बार-बार सीटी जैसी आवाज, खाँसी, साँस फूलना और छाती में जकड़न हो सकती है। यह छूने या साथ बैठने से नहीं फैलता।

हर बार की सीटी अस्थमा नहीं है, विशेषकर छोटे बच्चों में। चिकित्सक लक्षणों के क्रम, परीक्षण और उपचार पर प्रतिक्रिया सहित उपयुक्त आधार पर निदान करते हैं।

नियंत्रण के मुख्य घटक (Components of Control)

घटक	उपयोग
व्यक्तिगत उपचार-योजना	नियमित तथा जरूरत के उपचार को स्पष्ट करना
सही इनहेलर तकनीक	दवा को उपयुक्त रूप से वायुमार्ग तक पहुँचाना
आवश्यक स्पेसर (**Spacer**)	छोटे बच्चे में तकनीक सुगम बनाना
ज्ञात उद्दीपकों से बचाव	धुआँ तथा संबंधित संपर्क कम करना
नियमित समीक्षा	लक्षण, गतिविधि और बिगड़ने के प्रकरण देखना

सक्रिय जीवन और सुरक्षा (Participation and Safety)

उचित नियंत्रण में अधिकांश बच्चे खेल और विद्यालयी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। डर के कारण सभी गतिविधियाँ रोक देना उचित नहीं। उपचार स्वास्थ्यकर्मी की योजना के अनुसार हो; नियमित दवा अपने से बंद न करें।

बहुत कठिन श्वसन, बोलने या पीने में असमर्थता, नीलापन अथवा सुस्ती आपात संकेत हैं।

> इनहेलर का उपयोग बीमारी बिगड़ने का प्रमाण नहीं; सही दवा और सही तकनीक नियंत्रण के महत्त्वपूर्ण साधन हैं।

बचपन में मधुमेह और अन्य दीर्घकालीन दशाएँ

Childhood Diabetes and Chronic Conditions

टाइप 1 मधुमेह (Type 1 Diabetes)

टाइप 1 मधुमेह में प्रायः प्रतिरक्षा-संबंधी प्रक्रिया से इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएँ प्रभावित होती हैं। इंसुलिन की कमी रक्त-शर्करा और चयापचय को बिगाड़ती है। इसे केवल अधिक मिठाई खाने का परिणाम कहना गलत है।

अधिक प्यास, बार-बार पेशाब, वजन घटना और थकान महत्त्वपूर्ण संकेत हैं। टाइप 2 मधुमेह भी बच्चों में हो सकता है; उम्र अकेले प्रकार तय नहीं करती।

तात्कालिक जोखिम (Urgent Risk)

उलटी, पेट-दर्द, गहरी या कठिन साँस, निर्जलीकरण और सुस्ती के साथ मधुमेह की आशंका में कीटोएसिडोसिस (**Ketoacidosis**) जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है। शीघ्र चिकित्सा आवश्यक है।

देखभाल का पक्ष	महत्त्व
निर्धारित इंसुलिन तथा निगरानी	टाइप 1 मधुमेह का आवश्यक प्रबंधन
भोजन और गतिविधि की योजना	दैनिक जीवन तथा उपचार में समन्वय
बीमारी के समय की योजना	शर्करा और अन्य जोखिम का प्रबंधन
परिवार-विद्यालय सहयोग	सुरक्षित सहभागिता और समय पर सहायता

दीर्घकालीन सहयोग (Long-term Support)

अन्य दीर्घकालीन दशाओं में भी नियमित उपचार, अनुवर्तन और दैनिक कार्यों के अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है। बीमारी का अर्थ बच्चे की पूरी पहचान नहीं है।

> टाइप 1 मधुमेह में केवल आहार बदलना इंसुलिन का विकल्प नहीं; उपचार प्रशिक्षित टीम की व्यक्तिगत योजना के अनुसार चलता है।

विकासात्मक कठिनाइयाँ और कार्यात्मक स्वास्थ्य

Developmental Difficulties and Functional Health

समग्र स्वास्थ्य का भाग (Part of Overall Health)

दृष्टि, श्रवण, गति, भाषा या सीखने की कठिनाई बच्चों की स्वास्थ्य जरूरतों का महत्त्वपूर्ण भाग है। हर विकासात्मक भिन्नता बीमारी नहीं है, लेकिन जरूरत की पहचान और उपयुक्त सहायता टालना भी उचित नहीं है।

जन्मजात दशा, तंत्रिका-विकास संबंधी स्थिति और बाद की बीमारी या चोट अलग कारण हो सकते हैं। कठिनाई का रूप तथा दैनिक सहभागिता व्यक्ति के अनुसार बदलती है।

संकेत	आवश्यक दिशा
आवाज या संवाद पर कम प्रतिक्रिया	श्रवण तथा विकास का आकलन
गति में लगातार असमानता	गत्यात्मक और तंत्रिका मूल्यांकन
भाषा या सीखने में निरंतर कठिनाई	अवसर, भाषा-अनुभव और विशेषज्ञ समीक्षा
पहले आए कौशल खोना	शीघ्र चिकित्सीय मूल्यांकन

सहायता और समावेशन (Support and Inclusion)

आरंभिक सहयोग, अनुकूल उपकरण, संचार के विकल्प और परिवार-शिक्षक समन्वय बच्चे की सहभागिता बढ़ाते हैं। बच्चे की ताकत, रुचि और पसंद को योजना में शामिल करें।

किसी एक स्क्रीनिंग परिणाम से अंतिम निदान नहीं किया जाता। घर, केंद्र और विद्यालय की जानकारी मिलाकर उचित मूल्यांकन होना चाहिए।

सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण (Respectful Approach)

अक्षमता को नैतिक दोष या परिवार की असफलता न मानें। वातावरण की बाधाएँ हटाना और सेवाएँ सुलभ बनाना भी निवारण का भाग है।

> सहायता का उद्देश्य सभी बच्चों को एक जैसा बनाना नहीं; स्वास्थ्य, क्षमता और अर्थपूर्ण सहभागिता बढ़ाना है।

भावनात्मक और व्यवहारगत स्वास्थ्य

Emotional and Behavioural Health

रुग्णता का कम दिखाई देने वाला पक्ष (Less Visible Health Needs)

भय, उदासी, चिड़चिड़ापन, नींद में बदलाव या विद्यालय से बचना बच्चे की परेशानी का संकेत हो सकता है। हर अस्थायी प्रतिक्रिया मानसिक विकार नहीं है। अवधि, तीव्रता और दैनिक कार्य पर प्रभाव देखकर स्थिति समझी जाती है।

शरीर और मन का संबंध (Mind-Body Interaction)

चिंता पेट-दर्द या सिर-दर्द के रूप में व्यक्त हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ शारीरिक कारण की जाँच छोड़ना नहीं है। दीर्घकालीन शारीरिक बीमारी भी भावना और साथी-संबंधों को प्रभावित कर सकती है।

सहायक व्यवहार	उद्देश्य
ध्यान से सुनना	परेशानी और परिस्थिति समझना
नियमित नींद और दिनचर्या	स्थिरता तथा नियमन
खेल, संबंध और सहभागिता	अपनापन और अभिव्यक्ति
उपहास तथा कठोर दंड से बचाव	सुरक्षित वातावरण
लगातार कठिनाई में विशेषज्ञ सहायता	उपयुक्त मूल्यांकन और उपचार

लेबल से बचाव (Avoiding Labels)

अत्यधिक गतिविधि, कम बोलना या पढ़ाई में कठिनाई का अकेला उदाहरण किसी विकार का अंतिम प्रमाण नहीं है। संदर्भ, विकास, स्वास्थ्य और कई स्थितियों में व्यवहार देखना आवश्यक है।

परिवार और शिक्षक अवलोकन साझा करें। गंभीर सुरक्षा-संबंधी चिंता या तेजी से बिगड़ती स्थिति में तत्काल योग्य सहायता लें।

> भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल बच्चे की शारीरिक स्वास्थ्य सेवा से अलग नहीं; समग्र विकास का आवश्यक भाग है।

निवारण के स्तर और उनकी उपयोगिता

Levels of Prevention

रोग से पहले और बाद की कार्रवाई (Levels of Prevention)

निवारण केवल टीका लगाना नहीं है। स्वस्थ परिस्थितियाँ बनाना, जोखिम घटाना, जल्दी पहचान और उपचार के बाद सहभागिता बनाए रखना सभी उसके भाग हैं।

रोग से पहले	शुरुआती बीमारी	रोग के बाद
Before Illness	Early Illness	After Illness
जोखिम कम करना और सुरक्षा	जल्दी पहचान और उचित उपचार	जटिलता घटाना और पुनर्वास

स्तरों का अंतर (Distinguishing the Levels)

स्तर	अर्थ	उदाहरण
आद्य निवारण (**Primordial**)	जोखिम-कारक पैदा करने वाली परिस्थितियाँ कम करना	सुरक्षित भोजन, स्वच्छ हवा और स्वास्थ्यसमर्थक परिवेश
प्राथमिक निवारण (**Primary**)	रोग शुरू होने से पहले बचाव	टीकाकरण, हाथ धोना और उपयुक्त पोषण
द्वितीयक निवारण (**Secondary**)	जल्दी पहचान और उचित उपचार	दृष्टि जाँच, शुरुआती रोग का उपचार
तृतीयक निवारण (**Tertiary**)	जटिलता तथा अक्षमता का प्रभाव कम करना	पुनर्वास और दीर्घकालीन रोग में सहभागिता-सहायता

एक बच्चे में कई स्तर (Multiple Levels Together)

अस्थमा वाले बच्चे के लिए धुएँ से बचाव, सही निदान, उपचार और स्कूल में सक्रिय सहभागिता सभी जरूरी हो सकते हैं। इनमें अलग स्तर की कार्रवाई साथ काम करती है।

किसी उपाय का स्तर उस संदर्भ में उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। हर जाँच को केवल इसलिए उपचार नहीं कह सकते कि वह अस्पताल में होती है।

> प्रभावी निवारण बीमारी की शुरुआत से पहले के अवसर और बीमारी के बाद की जरूरत दोनों को संबोधित करता है।

प्रतिरक्षा और टीकाकरण का आधार

Immunity and the Basis of Vaccination

सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा (Active and Passive Immunity)

सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बनाता है। टीकाकरण संबंधित रोगकारक के विरुद्ध सुरक्षा विकसित करने का नियंत्रित अवसर देता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बने हुए प्रतिरक्षी मिलते हैं; उसका प्रभाव सामान्यतः सीमित अवधि का होता है।

प्रतिरक्षा का रूप	उदाहरण
प्राकृतिक सक्रिय	किसी संक्रमण के बाद विकसित प्रतिक्रिया
कृत्रिम सक्रिय	टीके से विकसित प्रतिक्रिया
प्राकृतिक निष्क्रिय	अपरा से प्राप्त मातृ IgG; स्तन-दूध के स्थानीय रक्षात्मक घटक
कृत्रिम निष्क्रिय	जरूरत पर दिया गया विशिष्ट इम्युनोग्लोबुलिन

संक्रमण से प्रतिरक्षा मिल सकती है, लेकिन बीमारी करके सुरक्षा लेना सुरक्षित रणनीति नहीं है। रोग की जटिलता और दीर्घकालीन हानि का खतरा रहता है।

प्राथमिक श्रृंखला और बूस्टर (Primary Series and Boosters)

कई टीकों में पर्याप्त प्रतिक्रिया के लिए एक से अधिक खुराक और आगे बूस्टर आवश्यक होते हैं। एक टीका लगना सभी रोगों से सुरक्षा नहीं है। जन्म की पोलियो खुराक आगे की निर्धारित पोलियो खुराकों का स्थान नहीं लेती।

व्यक्ति और समुदाय (Individual and Community Protection)

अधिक कवरेज कुछ संक्रमणों का सामुदायिक संचरण कम कर सकती है। यह लाभ सभी रोगों में समान नहीं है; टिटनेस जैसे रोग में व्यक्ति की अपनी टीका-सुरक्षा विशेष महत्त्व रखती है।

> टीके का नाम, संबंधित रोग, खुराकों का क्रम और आयु साथ समझना जरूरी है।

राष्ट्रीय टीकाकरण का प्रमुख बाल एवं किशोर क्रम

Key Childhood and Adolescent Immunization Schedule

आयु के अनुसार क्रम (Age-based Schedule)

नीचे भारत में प्रमुख नियमित बाल टीकों का क्रम दिया है। जन्म की हेपेटाइटिस B खुराक यथाशीघ्र, अधिमानतः पहले 24 घंटे में दी जाती है। स्थानीय कार्यक्रम तथा बच्चे की पिछली खुराकों की समीक्षा आवश्यक है।

आयु	प्रमुख टीके
जन्म	BCG, OPV-0, हेपेटाइटिस B जन्म-खुराक
6 सप्ताह	OPV-1, पेंटावैलेंट-1, RVV-1, fIPV-1, PCV-1
10 सप्ताह	OPV-2, पेंटावैलेंट-2, RVV-2
14 सप्ताह	OPV-3, पेंटावैलेंट-3, RVV-3, fIPV-2, PCV-2
9 से 12 माह	MR-1, PCV बूस्टर, fIPV-3; संबंधित क्षेत्रों में JE-1
16 से 24 माह	MR-2, DPT बूस्टर-1, OPV बूस्टर; संबंधित क्षेत्रों में JE-2
5 से 6 वर्ष	DPT बूस्टर-2
10 वर्ष	Td
14 वर्ष की बालिकाएँ	राष्ट्रीय HPV कार्यक्रम के अनुसार एक खुराक
16 वर्ष	Td

संक्षेपों का अर्थ (Abbreviations)

OPV मौखिक और fIPV आंशिक खुराक वाला निष्क्रिय पोलियो टीका है। RVV रोटावायरस, PCV न्यूमोकोकस, MR खसरा-रूबेला और JE जापानी इंसेफलाइटिस से संबंधित हैं। पेंटावैलेंट में डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस B और Hib की सुरक्षा शामिल है।

किशोरी टीकाकरण (Adolescent Vaccination)

वर्ष 2026 में राष्ट्रीय HPV कार्यक्रम 14 वर्ष पूर्ण लेकिन 15 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए शुरू हुआ। यह आगे गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के जोखिम को घटाने का उपाय है।

> JE का समावेश निर्दिष्ट स्थानिक क्षेत्रों के अनुसार है। छूटी खुराकों की पूर्ति स्वास्थ्यकर्मी की आयु-अनुकूल योजना से होती है।

टीकाकरण की गुणवत्ता, सुरक्षा और छूटे अवसर

Vaccination Quality, Safety and Missed Opportunities

प्रभावी टीकाकरण (Effective Immunization)

उचित टीका, सही आयु तथा अंतराल, सही मात्रा और विधि तथा उपयुक्त भंडारण सभी महत्त्वपूर्ण हैं। शीत-श्रृंखला (**Cold Chain**) टीके की क्षमता बनाए रखने के लिए नियंत्रित व्यवस्था है; केवल ठंडा दिखना पर्याप्त नहीं है।

छूटी खुराकें (Missed Doses)

टीकाकरण कार्ड और उपलब्ध डिजिटल अभिलेख की समीक्षा करें। देर होने पर कई श्रृंखलाएँ फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पूर्ति टीका और आयु के नियमों के अनुसार होती है। अपनी तरफ से नया अंतराल न तय करें।

स्थिति	उचित समझ
हल्की सर्दी जैसी छोटी समस्या	हमेशा टीका रोकने का कारण नहीं; स्वास्थ्यकर्मी आकलन करें
गंभीर एलर्जी का पूर्व इतिहास	टीका-विशिष्ट चिकित्सीय समीक्षा आवश्यक
कुछ प्रतिरक्षा-संबंधी दशाएँ	विशेषकर जीवित टीकों पर व्यक्तिगत सलाह
टीके के बाद गंभीर प्रतिक्रिया	तत्काल उपचार और उचित सूचना

प्रतिकूल घटना (Adverse Event Following Immunization: AEFI)

टीके के बाद होने वाली घटना समय के संबंध को बताती है; हर घटना का कारण टीका सिद्ध नहीं होता। हल्का दर्द या बुखार और साँस की कठिनाई या गंभीर एलर्जी जैसी आपात स्थिति का महत्त्व अलग है।

टीका और पोषण पूरक (Vaccine versus Supplement)

विटामिन A जैसे पोषण पूरक टीकाकरण संपर्क पर दिए जा सकते हैं, लेकिन वे टीका नहीं हैं। उनका उद्देश्य तथा मात्रा अलग है।

> टीकाकरण का रिकॉर्ड, सही पूर्ति और सुरक्षित सेवा मिलकर संबंधित रोगों की रुग्णता कम करते हैं।

पोषण और वृद्धि से रोग-निवारण

Nutrition, Growth and Disease Prevention

पर्याप्त पोषण (Adequate Nutrition)

आहार में ऊर्जा के साथ प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज की पर्याप्तता आवश्यक है। भोजन की विविधता तथा सुरक्षित तैयारी बच्चे को आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त करने में सहायता देती है। केवल पेट भरना पोषण की पूरी पर्याप्तता नहीं है।

शिशु एवं छोटे बच्चे का भोजन (Infant and Young Child Feeding)

पहले छह माह केवल स्तनपान तथा छह माह से पर्याप्त पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखना महत्त्वपूर्ण है। बढ़ती आयु के साथ भोजन की मात्रा, बनावट और विविधता उपयुक्त रूप से बढ़ती हैं।

अभ्यास	रोग-निवारण से संबंध
विविध पारिवारिक भोजन	कई पोषक तत्वों की पर्याप्तता
भोजन तथा बर्तन की स्वच्छता	संक्रमण के संपर्क कम करना
बच्चे के संकेतों पर प्रतिक्रिया	उपयुक्त और कम तनाव वाला भोजन
नियमित वृद्धि की समीक्षा	समस्या का जल्दी पता लगाना
कमी पर उपयुक्त सहायता	विशिष्ट जोखिम का प्रबंधन

वृद्धि निगरानी (Growth Monitoring)

वजन तथा लंबाई-ऊँचाई को आयु और लिंग के उपयुक्त चार्ट पर देखकर समय की प्रवृत्ति समझी जाती है। एक ही माप से पूरी कहानी नहीं मिलती। लगातार कम वृद्धि में भोजन, बीमारी और सामाजिक कारणों की समीक्षा करें।

अधिकता का पक्ष (Excess Intake)

अत्यधिक ऊर्जा-समृद्ध लेकिन कम पोषक भोजन, मीठे पेय और कम सक्रियता भी स्वास्थ्य समस्या बढ़ा सकते हैं। सभी बच्चों को बिना कारण अधिक कैलोरी या पूरक देना उचित नहीं है।

> पोषण-निवारण में कमी तथा अधिकता दोनों से बचाव और बीमारी के साथ भोजन का समन्वय शामिल है।

जल, स्वच्छता और हाथों की सफाई

Water, Sanitation and Hand Hygiene

WASH का अर्थ (Water, Sanitation and Hygiene)

सुरक्षित पानी, स्वच्छता और स्वच्छ व्यवहार संक्रमण का संपर्क घटाते हैं। परिवार की जानकारी के साथ पानी, साबुन और उपयुक्त शौचालय की वास्तविक उपलब्धता भी आवश्यक है।

अवसर	महत्त्वपूर्ण व्यवहार
भोजन बनाने या खिलाने से पहले	साबुन-पानी से हाथ साफ करना
शौच या बच्चे का मल साफ करने के बाद	हाथ धोना और सुरक्षित मल निस्तारण
पानी का उपयोग	सुरक्षित भंडारण और साफ पात्र
भोजन की तैयारी	पर्याप्त पकाना, ढकना और सुरक्षित रखना
साझा खेल-सामग्री	उपयोग तथा संदूषण के अनुसार सफाई

केवल दिखाई देने वाली गंदगी नहीं (Beyond Visible Dirt)

हाथ या पानी साफ दिखने पर भी रोगाणु हो सकते हैं। पीने के पानी को खुले पात्र में बार-बार हाथ डालकर निकालने से पुनःदूषण हो सकता है। सुरक्षित भंडारण भी उपचार जितना महत्त्वपूर्ण है।

आयु-अनुकूल आदतें (Age-appropriate Habits)

छोटे बच्चे को उदाहरण देकर हाथ धोना सिखाएँ और आवश्यक सहायता दें। शौच संबंधी दुर्घटना पर दंड देने के बजाय स्वच्छता और तैयारी में सहयोग करें।

बच्चे के मल को हमेशा निरापद समझना गलत है। सफाई करते समय देखभालकर्ता की सुरक्षा और हाथों की स्वच्छता दोनों आवश्यक हैं।

> स्वच्छ व्यवहार तभी टिकता है जब उसके लिए समय, पानी, साबुन और उपयुक्त सुविधा उपलब्ध हो।

सुरक्षित वातावरण, सक्रियता और विश्राम

Safe Environments, Activity and Rest

रोग और चोट का साझा निवारण (Healthy and Safe Environments)

धुएँ से बचाव, पर्याप्त वायु-संचार, मच्छर-नियंत्रण और सुरक्षित खेल-स्थान विभिन्न स्वास्थ्य जोखिम घटाते हैं। केवल एक रोग से बचाव के लिए बनाए नियम दूसरे विकासात्मक अवसरों को अनावश्यक रूप से बाधित न करें।

पर्यावरण का पक्ष	आवश्यक दिशा
हवा	तंबाकू और अन्य हानिकारक धुएँ से बचाव
मच्छर	ठहरा पानी कम करना और उपयुक्त काटने से सुरक्षा
घर	दवा, रसायन, गर्म द्रव और ऊँचाई सुरक्षित करना
खेल	आयु तथा क्षमता के अनुसार सक्रिय अवसर
विश्राम	नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद

सक्रिय जीवन (Physical Activity)

खेल, चलना और आयु-अनुकूल दैनिक काम शरीर, नींद और भावनात्मक स्वास्थ्य को सहारा देते हैं। दीर्घकालीन रोग या अक्षमता में गतिविधि को अनुकूल करें; हर बच्चे से एक जैसा प्रदर्शन अपेक्षित न हो।

नींद और स्क्रीन (Sleep and Screens)

अत्यधिक स्क्रीन से नींद, भोजन और जीवंत संवाद के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। परिवार सामग्री, समय और दैनिक संतुलन पर ध्यान दे। शिशु की सुरक्षित निद्रा में पीठ के बल लिटाना, दृढ़ समतल सतह और ढीली मुलायम सामग्री हटाना महत्त्वपूर्ण है।

> रोग-निवारण का वातावरण बच्चे को सुरक्षित रखते हुए खेल, संबंध और सीखने के अवसर भी देता है।

औषधियों का सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग

Safe and Rational Use of Medicines

आयु और मात्रा का महत्त्व (Age and Dose)

बच्चे की दवा केवल वयस्क की दवा का अंदाजे से छोटा भाग नहीं है। आयु, वजन, रोग, दवा की सांद्रता और शरीर की स्थिति के अनुसार मात्रा तय होती है। समान नाम की सिरप में भी अलग सांद्रता हो सकती है।

सुरक्षा का पक्ष	व्यवहार
सही दवा	नाम, उपयोग और पर्चे की पुष्टि
सही माप	दिए गए मापक या मौखिक सिरिंज का उपयोग
सही समय	निर्धारित अंतराल और अवधि का पालन
भंडारण	बंद, सुरक्षित और बच्चे की पहुँच से दूर
अनुवर्तन	लाभ, दुष्प्रभाव और जरूरी समीक्षा

एंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance)

अनावश्यक या गलत उपयोग प्रतिरोध बढ़ा सकता है। सामान्य विषाणुजनित सर्दी में एंटीबायोटिक लाभ नहीं देती। बची दवा देना, दूसरे बच्चे का पर्चा अपनाना या स्वयं मात्रा बदलना उचित नहीं है।

घरेलू उपाय और मिश्रित औषधियाँ (Home Remedies and Combinations)

“प्राकृतिक” लिखा होना सुरक्षा का प्रमाण नहीं है। मिश्रित दवाओं में एक ही घटक दोहरने से अधिक मात्रा मिल सकती है। तेज रसायन, अज्ञात जड़ी-बूटी और तेल निगलवाना हानिकारक हो सकता है।

आँख, कान और त्वचा की दवा भी समस्या के कारण के अनुसार चुनी जाती है।

> उपचार में सही पहचान और सही मात्रा आवश्यक हैं; केवल लक्षण दबना रोग के ठीक होने का पूरा प्रमाण नहीं।

घरेलू निगरानी और तत्काल रेफरल

Home Monitoring and Urgent Referral

घर पर क्या देखें? (Home Observation)

बीमारी के क्रम में भोजन, द्रव, पेशाब, सक्रियता, श्वसन और चेतना की निगरानी उपयोगी है। बच्चे की सामान्य स्थिति से नया बदलाव महत्त्वपूर्ण सूचना है।

संकेत	कार्रवाई
पी न पाना या स्तनपान न कर पाना	तत्काल चिकित्सीय मूल्यांकन
सब कुछ उलट देना	शीघ्र गंभीरता की जाँच
दौरा, अचेतना या असामान्य सुस्ती	आपात सहायता
कठिन श्वसन या नीलापन	तत्काल आपात सेवा
गंभीर निर्जलीकरण या तेजी से बिगड़ना	बिना विलंब सक्षम केंद्र

छोटे शिशु में सावधानी (Young Infant Concerns)

नवजात या बहुत छोटे शिशु में दूध कम पीना, कम गति, ताप की असामान्यता या कठिन श्वसन ही गंभीर रोग का संकेत हो सकता है। लक्षण बहुत स्पष्ट होने की प्रतीक्षा उचित नहीं है।

सुरक्षित सहायता (Safe Help-seeking)

चिकित्सक को लक्षण शुरू होने का समय, भोजन, पेशाब और दी गई दवा की जानकारी दें। पर्चे तथा जरूरी अभिलेख साथ रखें। जरूरत पर रेफरल-स्थान और परिवहन का समन्वय करें।

अचेत या निगल न सकने वाले बच्चे को मुँह से पानी, भोजन या दवा जबरन न दें। यदि गंभीर संकेत हों, तो केवल बुखार उतरने या अगली नियत मुलाकात की प्रतीक्षा न करें।

> सभी खतरे के संकेत एक साथ होना आवश्यक नहीं; किसी एक गंभीर संकेत पर कार्रवाई जरूरी हो सकती है।

एकीकृत नवजात एवं बाल रोग प्रबंधन

Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness

IMNCI का उद्देश्य (Integrated Management)

IMNCI बीमार नवजात और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे की प्रमुख समस्याओं का समग्र आकलन, वर्गीकरण और प्रबंधन करता है। बच्चा एक साथ दस्त, श्वसन रोग और पोषण समस्या से प्रभावित हो सकता है।

1	**आकलन**	आयु, खतरे के संकेत और प्रमुख समस्याएँ।
2	**वर्गीकरण**	गंभीरता और आवश्यक सेवा का स्तर।
3	**उपचार तथा रेफरल**	परिस्थिति के अनुसार योग्य कार्रवाई।
4	**परामर्श और अनुवर्तन**	भोजन, दवा, वापसी का समय और समीक्षा।

आयु-अनुकूल आकलन (Age-specific Assessment)

छोटे शिशु और दो माह से पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे की आकलन-पद्धति में अंतर है। सामान्य खतरे के संकेतों के साथ श्वसन, दस्त, बुखार, कान, पोषण और अन्य आवश्यक पक्ष देखे जाते हैं।

वर्गीकरण और कार्रवाई (Classification and Action)

प्रचलित रंग-आधारित चार्ट में गुलाबी श्रेणी तत्काल रेफरल या अस्पताल सेवा, पीली श्रेणी विशिष्ट बाह्य-रोगी उपचार और हरी श्रेणी उचित घरेलू देखभाल से संबंधित होती है। वास्तविक निर्णय आयु-अनुकूल चार्ट और प्रशिक्षित आकलन से किया जाता है।

परामर्श और अनुवर्तन (Counselling and Follow-up)

परिवार को दवा, भोजन, द्रव, खतरे के संकेत और दोबारा आने का समय स्पष्ट करें। केवल सलाह देने के बजाय उनसे अपने शब्दों में समझ बताने को कहें; इससे गलतफहमी पहचानी जा सकती है।

> वर्गीकरण गंभीरता और कार्रवाई तय करने का साधन है; हर श्रेणी का अर्थ किसी एक प्रयोगशाला-पुष्ट रोग का नाम नहीं होता।

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और आरंभिक सहायता

Child Health Programmes and Early Intervention

व्यापक सेवाओं से जुड़ाव (Linkage with Services)

बीमारी की रोकथाम के लिए घर, आँगनवाड़ी, विद्यालय और स्वास्थ्य सुविधा की सेवाएँ जुड़ी हों। नवजात तथा छोटे बच्चे की घरेलू देखभाल, टीकाकरण, पोषण और बीमारी का उपचार एक-दूसरे को सहारा देते हैं।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)

RBSK जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों में चार D के अंतर्गत स्वास्थ्य जरूरतों की पहचान तथा सेवा से जोड़ने का कार्यक्रम है। 2026 के RBSK 2.0 विवरण में 32 सामान्य स्वास्थ्य दशाएँ शामिल हैं।

चार D	हिंदी अर्थ
Defects at Birth	जन्मजात विकार
Diseases	रोग
Deficiencies	पोषण संबंधी कमियाँ
Developmental Delays	विकास में विलंब तथा संबंधित जरूरतें

जिला आरंभिक हस्तक्षेप केंद्र (DEIC)

DEIC मूल्यांकन, आरंभिक सहायता, अनुवर्तन और जरूरत पर उच्चतर सेवा से जोड़ने में भूमिका निभाते हैं। स्क्रीनिंग में समस्या की आशंका मिलना अंतिम निदान के समान नहीं है।

कार्यक्रम से वास्तविक लाभ (Effective Linkage)

पहचान के बाद परिवार को कब, कहाँ और किस सेवा के लिए जाना है, यह स्पष्ट हो। यात्रा, भाषा, खर्च या सामाजिक बाधा होने पर अतिरिक्त सहयोग आवश्यक हो सकता है। बार-बार स्क्रीनिंग करके भी उपचार तक न पहुँच पाना अधूरी सेवा है।

> आरंभिक पहचान का लाभ तभी मिलता है जब उचित मूल्यांकन, उपचार और अनुवर्तन उपलब्ध हों।

परिवार, शिक्षक और समुदाय की भूमिका

Roles of Family, Teachers and Community

साझा उत्तरदायित्व (Shared Responsibility)

परिवार बच्चे की रोज की स्थिति जानता है। शिक्षक सहभागिता, सुनने-देखने और अनुपस्थिति के बदलते क्रम देख सकता है। समुदाय और स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक सेवा तक पहुँच बनाने में सहायता करते हैं।

भूमिका	उपयोगी कार्य
परिवार	टीका, भोजन, दवा और बीमारी का अभिलेख
शिक्षक	बार-बार अनुपस्थिति या व्यवहार में बदलाव की पहचान
सामुदायिक कार्यकर्ता	जानकारी, अनुवर्तन तथा सेवा से जोड़ना
स्वास्थ्य सेवा	निदान, उपचार, परामर्श और रेफरल

संवाद और गोपनीयता (Communication and Privacy)

स्वास्थ्य जानकारी जरूरत के अनुसार और सम्मानपूर्वक साझा करें। बीमारी या अक्षमता के कारण बच्चे को सार्वजनिक रूप से चिह्नित या अपमानित करना उचित नहीं है। दीर्घकालीन बीमारी में जरूरी देखभाल-योजना संबंधित वयस्कों को समझ होनी चाहिए।

छोटे प्रकोप पर कार्रवाई (Responding to Clusters)

यदि एक ही स्थान या भोजन से जुड़े कई बच्चे समान लक्षण दिखाएँ तो सुरक्षित देखभाल के साथ स्वास्थ्य सेवा को सूचना दें। समय, स्थान और लक्षण दर्ज करना उपयोगी है। अनुमान के आधार पर किसी परिवार या भोजन-विक्रेता को दोष देना जाँच का विकल्प नहीं है।

सहभागिता बनाए रखना (Maintaining Participation)

रोग की स्थिति और चिकित्सीय सलाह के अनुसार स्कूल वापसी तथा गतिविधि तय करें। जहाँ अनुकूलन आवश्यक हो, उसे उपलब्ध कराएँ।

> स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य जानकारी याद कराना भर नहीं; परिवार को व्यवहार करने और सही समय पर सहायता लेने में सक्षम बनाना है।

रोग-निवारण का समेकित अध्ययन

An Integrated Approach to Disease Prevention

समस्या और उपयुक्त कार्रवाई (Problem-to-action Matrix)

परिस्थिति	मुख्य समझ	निवारण तथा सहायता
बार-बार हल्की सर्दी	हर प्रकरण जीवाणुजनित नहीं	स्वच्छता, धुएँ से बचाव और गंभीरता की निगरानी
दस्त और कम पेशाब	द्रव-हानि का जोखिम	सही ORS, भोजन और आवश्यक रेफरल
कम वृद्धि तथा बार-बार संक्रमण	पोषण और बीमारी का दोतरफा संबंध	वृद्धि की समीक्षा, आहार तथा रोग-प्रबंधन
रात की खुजली और परिवार में लक्षण	स्केबीज की संभावना	सही निदान और संपर्कों का उपयुक्त उपचार
बार-बार श्वसन सीटी	अलग कारण संभव; अस्थमा की समीक्षा	व्यक्तिगत योजना और सही इनहेलर तकनीक
अधिक प्यास, पेशाब और वजन घटना	मधुमेह का संकेत हो सकता है	शीघ्र जाँच; गंभीर लक्षण पर आपात सेवा
बोर्ड या आवाज समझने में कठिनाई	दृष्टि या श्रवण का पक्ष संभव	मूल्यांकन और उपयुक्त अनुकूलन

एक संकेत से निष्कर्ष नहीं (Avoiding Single-sign Diagnosis)

ऊपर की स्थितियाँ समझाने के उदाहरण हैं। समान संकेत के कई कारण हो सकते हैं। आयु, अवधि, परीक्षण और वास्तविक परिस्थिति के आधार पर निर्णय होता है।

योजना का मूल्यांकन (Evaluating the Plan)

बचाव की सलाह के बाद देखें कि परिवार के पास आवश्यक साधन हैं या नहीं। उपचार के बाद सुधार, दुष्प्रभाव, भोजन और दैनिक सहभागिता की समीक्षा करें।

> कारण समझना, गंभीरता पहचानना, सही सेवा देना और परिणाम देखना एक सतत प्रक्रिया है।

प्रमुख संकल्पनाएँ और समग्र दृष्टिकोण

Key Concepts and a Holistic Perspective

आवश्यक अंतर (Key Distinctions)

संकल्पनाएँ	महत्त्वपूर्ण अंतर
रुग्णता और मृत्यु	बीमारी की उपस्थिति; जीवन का समाप्त होना
आपतन और व्याप्तता	नए मामले; सभी मौजूद संबंधित मामले
रोगी और प्रकरण	एक बच्चा; उसी बच्चे में एक या अनेक अलग घटनाएँ
तीव्र और दीर्घकालीन रोग	अवधि तथा क्रम का अंतर; गंभीरता अलग पक्ष
स्क्रीनिंग और निदान	अतिरिक्त मूल्यांकन की जरूरत पहचानना; रोग की पुष्टि करना
संक्रमण और संचरण	रोगकारक का प्रभाव; एक से दूसरे तक पहुँचने का रास्ता
टीका और इम्युनोग्लोबुलिन	सक्रिय प्रतिरक्षा विकसित करना; बने प्रतिरक्षी देना
ORS और जिंक	द्रव-लवण की पूर्ति; दस्त-प्रबंधन का अलग सहायक

समग्र निवारण (Comprehensive Prevention)

उपयुक्त पोषण, टीकाकरण, स्वच्छता, सुरक्षित वातावरण और सक्रिय जीवन बीमारी का जोखिम घटाते हैं। शुरुआती पहचान तथा समय पर उपचार गंभीरता कम करते हैं। दीर्घकालीन दशा में अनुवर्तन और समावेशी सहयोग आवश्यक रहता है।

रुग्णता का अध्ययन आँकड़ों तक सीमित नहीं है। खेल, भोजन, नींद, सीखने और संबंधों में बच्चे की स्थिति भी महत्त्वपूर्ण है। परिवार के संसाधन तथा बाधाएँ समझकर व्यवहारिक योजना बनाई जानी चाहिए।

विकास और स्वास्थ्य (Health and Development)

स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य बीमारी का नाम तय करने के साथ बच्चे की कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता बेहतर करना है। बच्चे की बात और अनुभव को भी योजना का भाग बनाएँ।

> प्रभावी बाल स्वास्थ्य देखभाल रोकथाम, उपचार, विकास और सम्मानपूर्ण सहभागिता को एक साथ जोड़ती है।